

INFILTRACIÓN DE TOBILLO

Ana Peñalver Andrada, Ester Garrido López, Carolina Cordero Raverol, Juan José González Fernández.

INDICACIONES

- Neurinoma de Morton.
- Fascitis plantar.
- Espolón calcáneo.
- Síndrome del seno del tarso.

NEURINOMA DE MORTON

Neuropatía por atrapamiento del nervio digital plantar en espacios intermetatarsianos (más frecuentemente entre el tercer y cuarto metatarsiano) que produce dolor lancinante con disestesias en dedos contiguos. Aparece habitualmente como consecuencia del uso prolongado de un calzado puntiagudo y con tacón alto que comprime el antepie.

Técnica de infiltración

- Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada y el pie en flexión y apoyo plantar.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Con aguja intramuscular, perpendicular al plano cutáneo, desde dorsal y hacia plantar se entra en el 2 ó 3 espacio interdigital atravesando el ligamento intermetatarsiano, sobre el punto de máximo dolor ligeramente oblicuo. Infiltrar 0,25- 1 mL de mezcla cortico-anestésica.



Material

- Aguja subcutánea y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 0,5 cc de corticoide depot y 0,2 cc de anestésico:
 - Corticoide depot: - Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
 - Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
 - Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
 - Anestésico local: Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor.

FASCITIS PLANTAR Y ESPOLÓN CALCÁNEO

La fascitis plantar es una lesión de la inserción posterior de la fascia plantar y de los músculos flexores cortos en el calcáneo, produciendo inflamación de la aponeurosis plantar, que se suele deber a la sobrecarga de tensión a la que es sometida. Produce dolor sordo a la presión de la zona y con la dorsiflexión de los dedos.

El espolón calcáneo es una exostosis ósea secundaria al acúmulo de calcio por microtraumatismos o inflamaciones de repetición. Pueden estar a nivel subcalcáneo (inserción fascia plantar) o retrocalcáneo posterior (inserción tendón de Aquiles). Produce dolor difuso a nivel del talón sin existir correlación clínico- radiológica.

Técnica de infiltración

- Paciente en decúbito supino con el pie en rotación externa.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Por ser una zona dolorosa, primero con aguja subcutánea se pone el anestésico local (lidocaína o mepivacaína al 1-2%).
- Con aguja intramuscular, en un ángulo aproximado de 45º, se entra por el borde interno hacia el punto de máximo dolor en el talón, paralelo al plano óseo, llegando hasta el hueso e infiltrando en abanico pegado al hueso. Infiltrar 0,5-1 mL de mezcla corticoanestésica.

Material

- Aguja subcutánea y jeringa de 5-10 mL.
- Anestésico local: lidocaína o mepivacaína al 1-2%.
- Aguja intramuscular y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 1 cc de corticoide depot y 0,5 cc de anestésico:
 - **Corticoide depot:**
 - Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
 - Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
 - Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
 - **Anestésico local:** Mepivacaína 1% ó 2%.

SÍNDROME DEL SENO DEL TARSO

El seno del tarso es un compartimiento anatómico situado en la zona lateral del retropié, entre la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo. Continuas lesiones en esta zona del retropié pueden producir un cuadro clínico que se caracteriza por persistencia de dolor en la región anterolateral de tobillo y/o retropié que se conoce como síndrome del seno del tarso. El dolor se localiza a punta de dedo en el seno del tarso.

Técnica de infiltración

- Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada y el pie en flexión y apoyo plantar.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Con aguja intramuscular, se localiza el punto de entrada al seno en el lado externo, unos 2cm por debajo del maléolo externo y 2 cm por delante y, desde ahí, se entra perpendicular. Infiltrar 0,5-1 ml de mezcla corticoanestésica.

Material

- Aguja intramuscular y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 0,5 cc de corticoide depot y 0,2 cc de anestésico:
 - **Corticoide depot:**

- Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
- Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
- Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
- **Anestésico local:** Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor.

BIBLIOGRAFÍA

- R.C. Álvarez Sciamanna, M.H. Dodangeh González. Capítulo 12: infiltraciones en COT. En: M.A, Arilla Castilla.SECOT. Manual del Residente. Hospital ASEPEYO, Coslada. Madrid. Disponible en: http://unitia.secot.criticssl.com/web/manual_residente/CAPITULO%2012.pdf.
- L.N. Massip, I.R. Franco. Infiltraciones (I y II). AMF 2010; 6(3): 147-152. Disponible en: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=44
- J.S. Genovés, V.G.Ruiz, C.F. Carrascosa, et al. Manual de infiltraciones en Atención Primaria. Comunidad Valenciana: Generalitat. Conselleria de Sanitat; 2007. Disponible en: <http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.5192-2007.pdf>